

УДК: 616.329-006.6-073.75:615-036.8

Е.Б.Ижсанов, Ж.Ж. Жолдыбай, Г.С. Ахметова, Р.З. Абдрахманов, Е.Ш.Абзалбек
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Лучевые методы исследования в оценке распространённости процесса и эффективности лечения рака пищевода

Аннотация. Лучевые методы исследования (рентген-контрастное исследование, компьютерная томография) улучшают диагностику рака пищевода и позволяют провести объективную достоверную оценку состояния стенок органа и окружающих регионарных зон, что позволяет изначально выработать оптимальную тактику лечения. Проведение

РКТ при раке пищевода целесообразно всем пациентам, планируемым на оперативное лечение, в целях оценки распространённости и резектабельности опухолевого процесса. РКТ в сочетании с рентгенконтрастным ис-

следованием позволяют оценить результаты неoadъювантной химиолучевой терапии рака пищевода по схеме таксотер+цисплатин в комбинации с конформной лучевой терапией.

Ключевые слова: рак пищевода, рентгенконтрастное исследование, компьютерная томография

Рентгенологическое исследование остается одним из ведущих методов, используемых в диагностике органического поражения пищевода. По данным ряда авторов, специфичность метода составляет 97-99% [1,2].

В настоящее время в обследовании больных раком пищевода для оценки распространённости процесса, изучения состояния лимфатических узлов ведущую роль имеет рентгеновская компьютерная томография (РКТ) [3,4].

Для выбора адекватного метода лечения необходимо изучение состояния как первичного очага, так и определения распространённости процесса.

Цель работы: оценить возможности лучевых методов исследования в определении распространённости процесса и оценке эффективности химиолучевой терапии рака пищевода.

Материалы и методы: исследования выполнены 30 больным раком пищевода в возрасте от 47 до 63 лет, средний

возраст составил 52,4 лет.

Исследования проводились пациентам, находившимся на стационарном лечении в отделении химиотерапии КазНИИ онкологии и радиологии.

Рентгенологические исследования и компьютерная томография выполнялись в отделении рентгенодиагностики.

Всем пациентам до начала противоопухолевой терапии и после ее завершения проводилось рентгенконтрастное исследование пищевода на рентгеновском аппарате с цифровой приставкой (Agfa), рентгеновская компьютерная томография пищевода на компьютерном томографе «Aura» (Philips).

Учитывались следующие важные критерии оценки опухолевого процесса: локализация и характер роста опухоли; протяженность опухолевого процесса; характер изменений слизистой оболочки пищевода; степень сужения просвета пищевода, а также состояние окружающих органов и регионарных зон.

В неoadъювантном режиме пациентам проводилось 3 курса химиотерапии по схеме: доцетаксел (таксотер) 75 мг/м², цисплатин 75 мг/м² с межкурсовым интервалом 21 день и в сочетании с 3-м курсом лекарственного лечения курс конформной лучевой терапии РОД-2Гр, 5 фракций в неделю, СОД-50Гр. Спустя 3 недели после завершения химиолучевой терапии выполнялось оперативное лечение



до лечения



после лечения (через 4 месяца)

Рисунок 1- Рентгенконтрастное исследование пищевода

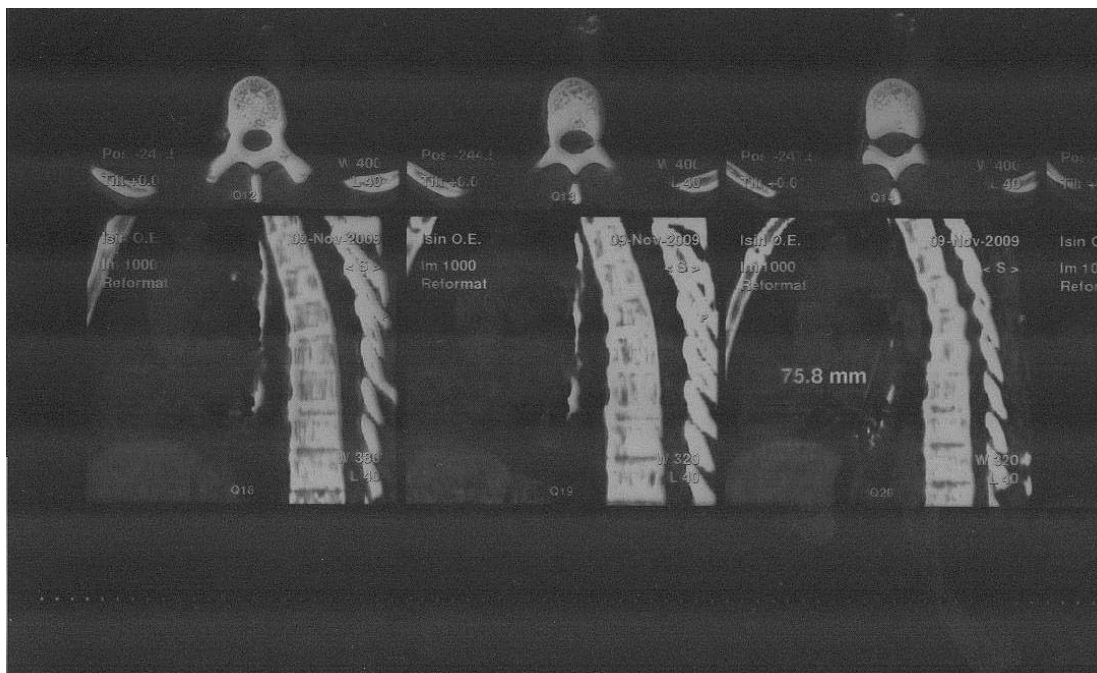


Рисунок 2 - Компьютерная томография пищевода

в объеме субтотальной резекции пищевода с одновременной гастропластикой и расширенной двухзональной лимфодиссекцией.

Результаты: по локализации процесса в пищеводе распределение больных выглядело следующим образом: среднегрудной отдел – 19 (63,3%) пациентов, нижнегрудной отдел – 11 (36,7%) пациентов.

Экзофитный рост отмечен в 21 (70%) случае, опухолевый рост смешанного характера наблюдался у 9 (30%) больных.

Протяженность опухоли до 4 см отмечена у 2 (6,7%) пациентов; от 4 до 6 см у 21 (70%) больных; свыше 6 см – в 7 (23,3%) случаях.

Пациентов с сужением просвета пищевода более 1,5 см было 16 (53,3%); от 1,0 см до 1,5 см – 11 (36,7%); менее 1,0 см – 3 (10%).

При контрольном рентгенологическом исследовании пищевода установлено, что общий объективный эффект получен у 19 (63,3%) больных, из них у 5 (16,6%) достигнута полная регрессия опухоли (рисунок №1), подтвержденная результатами морфологического послеоперационного исследования, частичная регрессия – у 14 (46,7%) больных, у 11 (36,7%) – стабилизация процесса.

Опухолевая инфильтрация на РКТ-срезах выглядела в виде неравномерного утолщения стенок и неровности контуров сужения просвета пищевода, толщина стенки при этом колебалась в пределах 7-22 мм, что наблюдалось у 19 (63,3%) больных (рисунок №2). У 11 (36,7%) пациентов при местно-распространенном процессе толщина стенок пищевода варьировала в пределах 26-28 мм.

При прорастании опухоли в смежные органы и структуры, наблюдаемое в нашем исследовании у 1 (3,3%) пациента, на РКТ-сканах выявлялась нечеткость контуров пищевода и окружающих тканей, что с определенной уверенностью позволяло утверждать о распространенном процессе.

Выводы

Лучевые методы исследования (рентгенконтрастное исследование, компьютерная томография) улучшают диагностику рака пищевода и позволяют провести объ-

ективную достоверную оценку состояния стенок органа и окружающих регионарных зон, что позволяет изначально выработать оптимальную тактику лечения. Проведение РКТ при раке пищевода целесообразно всем пациентам, планируемыми на оперативное лечение, в целях оценки распространенности и резектабельности опухолевого процесса. РКТ в сочетании с рентгенконтрастным исследованием позволяют оценить результаты неоадьювантной химиолучевой терапии рака пищевода по схеме таксотер+цисплатин в комбинации с конформной лучевой терапией.

Список литературы

1. Прокоп М.В., Галаксин М.С. Спиральная и многослойная компьютерная томография. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - Т. 1. - С. 11.
2. Кишковский А.Н. Дифференциальная рентгенодиагностика в гастроэнтерологии. - М.: Медицина, 1984. - С. 55.
3. Соколов Ю.Н., Антонович В.Б. Рентгенодиагностика опухолей пищеварительного тракта. - М.: Медицина, 1981. - С. 7.
4. Жолдыбай Ж.Ж., Жакенова Ж.Ж., Потапов О.В., Коростелева О.В. Комплексная лучевая диагностика во оценке эффективности лечения рака желудка // Мат. Республиканской научно-практической конф. «Актуальные проблемы клинической онкологии». - Семей, 2007. - С. 68-69.

Тұжырым

Е.Б.Ижсанов, Ж.Ж.Жолдыбай, Г.С.Ахметов,
Р.З.Абдрахманов, Е.Ш.Абзалбек

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Өңеш қатерлі ісігі кезінде емдеу тиімділігі мен сәуелі зерттеу әдістерін тексеру

Өңеш қатерлі ісігінде сәуелі зерттеу әдісі (рентгеноконтрастты зерттеу, компьютерлік томография) өңештің қабырғаларын және қоршаған аймақ жағдайын бағалауға көмектеседі. Өңештің жайылған және резектабельді қатерлі ісігі бар науқастарға оперативті ем кезінде РКТ жүргізген дұрыс болып саналады. Рентгеноконтрастты РКТ адьювантты емес химиосәуелі терапияны

таксотер+цисплатин конформды сәулелі терапияда қолдануға болады.

Түйінді сөздер: өңеш қатерлі ісігі, компьютерлі томография.

Summary

E.B. Izhanov, Z.Z. Zholdybai, G.S.Akhmetova, R.Z. Abdrahmanov, E.Sh.Abzalbek

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Radiological methods in the evaluation of the distribution process and the effectiveness of treatment for esophageal cancer.

The radial methods of investigation (x-ray contrast

examination, computed tomography) enhance esophageal cancer diagnosis and enable to perform an objective reliable assessment of organ walls conditions and surrounding regional zones, which makes it possible to develop an optimal therapeutic approach. In esophageal cancer it is reasonable to conduct roentgen computed tomography (RCT) to all patients intended for open treatment in order to assess the extension and respectability of tumor process. RCT in combination with x-ray contrast examination enables to assess the results of neoadjuvant chemo - radiation therapy in esophageal cancer; which makes it possible to perform a timely adjustment in the treatment provided.

Key words: oncology, esophageal cancer, chemotherapy